

13 - 01-Ulcérations de la muqueuse génitale - Pr. Amal

Bonjour. Le cours d'aujourd'hui est intitulé « Désultération de la muqueuse génitale ». Lorsqu'on parle de désultération de la muqueuse génitale, on pense systématiquement aux infections sexuellement transmissibles. Les infections sexuellement transmissibles représentent un problème de santé publique au Maroc.

300 à 400 000 nouveaux cas sont déclarés au Maroc, mais il y a des médecins qui ne déclarent pas, donc il faut prendre en considération que ce chiffre est au-dessous de la réalité. Les ulcérations génitales représentent 6 % de ces infections sexuellement transmissibles dominées par la syphilis que vous voyez ici, donc le chancre syphilitique, dit au treponema pallidum, le chancre mou, dit au bacille du ducrée, et l'herpège génitale. Bien sûr, en dehors des IST, il y a d'autres étiologies qu'on va voir par la suite.

Après ce cours, vous devrez être capable d'orienter le diagnostic étiologique d'une ulcération de la muqueuse génitale, diagnostiquer un chancre syphilitique, définir les réactions sévologiques de la syphilis et interpréter les résultats de ces réactions, diagnostiquer un chancre mou, diagnostiquer un chancre mixte, énumérer les autres étiologies d'ulcérations de la muqueuse génitale, planifier le traitement d'un chancre syphilitique, d'un chancre mou et d'un chancre mixte. Quelques définitions sémiologiques. L'ulcération est une perte de substance superficielle.

Ce que vous voyez ici, il y a le respect de la membrane basale. La même chose pour l'érosion. C'est une perte de substance superficielle, le plus souvent secondaire à la rupture d'une lésion à contenu liquidienne.

Rappelez-vous, les lésions à contenu liquidienne, ce sont les bulles, les vésicules et les pustules. Ou ça peut être également post-traumatique. Par contre, l'ulcération est une perte de substance qui est profonde, qui ne respecte pas la membrane basale.

L'ulcération, elle guérit en laissant une cicatrice, alors que l'érosion et l'exulcoration guérissent sans laisser de cicatrices. On parle de chancre lorsqu'on est devant une ulcération ou une érosion secondaire à la pénétration d'un micro-organisme, c'est-à-dire d'un agent infectieux. Par exemple, le chancre syphilitique, il est secondaire à la pénétration du trypanosome palidorum.

Le chancre mou, au Brachy de Ducreil. On parle également du chancre tuberculeux, par exemple, à pénétration de bacille. Les ulcérations de la muqueuse génitale sont des lésions élémentaires dont le diagnostic étiologique repose essentiellement sur l'anamnèse et l'examen clinique.

Ainsi, à l'interrogatoire, il faut préciser l'âge du patient, le sexe, l'état civil, célibataire ou marié, la profession, l'origine, la notion de voyage, la notion de rapports sexuels non protégés, le profil des partenaires, la notion de traumatisme local, la notion d'application d'autopique, la notion de prise médicamenteuse, parce qu'il existe certains médicaments qui peuvent donner comme effet

secondaire majeur des ulcérations de la muqueuse. A l'interrogatoire, on doit également préciser la date d'apparition de la lésion. Donc, c'est très important de faire la part entre une lésion aiguë qui évolue moins d'un mois, et à ce moment-là, on évoque plutôt les infections sexuellement transmissibles, et une lésion qui évolue plus d'un mois, donc une lésion chronique qui oriente plus vers une dermatose inflammatoire chronique, comme le lichen érosif, ou bien, surtout, il faut éliminer une dermatose néoplasique, le carcinome épidermoïde ou la maladie de Bowen.

L'intervalle entre la lésion et le rapport sexuel, également, il est très important de définir cet intervalle, parce qu'il permet de différencier entre les différentes maladies sexuellement transmissibles. Par exemple, dans le cadre du chancre syphilitique, cet intervalle, il est de trois semaines en moyen. Par contre, dans le cadre du chancre mou, cet intervalle, il est raccourci, il est de trois jours.

L'existence des signes fonctionnels, comme la douleur, oriente vers un chancre mou ou l'herpès, par exemple, ou une afte génitale. L'existence de brûlures, de prurites. Il faut préciser également, si ces lésions évoluent par poussée, c'est-à-dire qu'elles apparaissent puis disparaissent.

Donc, à ce moment-là, on est orienté vers l'herpès, par exemple, et l'afte génitale. L'existence d'autres signes qui orientent vers d'autres maladies sexuellement transmissibles, l'aniculum urétrale, qui oriente vers une uréthrite, peut-être d'origine gonococcique ou secondaire à d'autres infections qu'on va voir par la suite. L'existence des recorèges de la femme, l'existence des signes urinaires.

L'examen physique doit chercher et doit identifier les caractéristiques de l'ulcération, donc le nombre, la taille, la bordure, le fond. Est-ce que c'est un fond propre qui oriente vers le chancre syphilitique? Est-ce que c'est un fond périllant qui oriente plutôt vers le chancre mou? La consistance, est-ce que c'est une lésion souple ou est-ce que c'est une lésion endurée? Une lésion souple oriente vers le chancre mou, une lésion endurée oriente vers le chancre syphilitique. Cette consistance, donc, on apprécie en essayant de rapprocher les verges de l'ulcération.

Si on n'arrive pas à rapprocher ces verges, donc on est devant une lésion endurée. Il faut préciser également la topographie des ulcérations. Il faut chercher au niveau de la muqueuse génitale s'il y a d'autres lésions qui orientent vers d'autres infections sexuellement transmissibles.

Donc, chercher s'il y a des lésions de végétation vénériennes dues au papillomavirus. Chercher s'il y a un écoulement urethral, donc en faisant une pression sur l'urètre, orientant vers une uréthrite. Faire un examen des aires ganglionnaires à la recherche des adénopathies inguinales.

Et on termine par un... On va voir maintenant les différentes étiologies des ulcérations de la muqueuse génitale. Et on va commencer par les ulcérations aiguës. On a dit que devant toute ulcération aiguë de la muqueuse génitale, il faut penser aux infections sexuellement

transmissibles.

Donc, essentiellement, les infections sexuellement transmissibles sont dominées dans notre contexte par deux étiologies, le chancre syphilitique et le chancre mou. Donc, on va commencer par le chancre syphilitique. Il est dû au *Treponema pallidum*.

C'est une bactérie qui appartient à la famille des spirochettes, ce qu'on voyait au microscope électronique. C'est une bactérie... C'est une bactérie avec des spirales, des fines spirales à spires régulières et extrémités effilées. Donc, la longueur, elle est de 8 micromètres et le diamètre est de 0,25 micromètre.

Donc, le chancre syphilitique, il est secondaire à la pénétration du *Treponema pallidum*. Donc, la contamination et la transmission, il est direct et sexuel dans 95 % des cas. Peut-être direct, mais non sexuel de façon exceptionnelle suite à l'exposition à un agent contaminé par le *Treponema pallidum*.

Le chancre syphilitique se présente le plus souvent sous forme d'ulcération ou érosion de 0,5 à 2 centimètres de diamètre, propre, indolore et indurée. Donc, l'induration est le seul caractère sémiologique vraiment évocateur. Il se traduit par l'impossibilité de plisser entre deux doigts la surface de l'ulcération qui ne fait qu'un seul bloc avec l'induration sous-jacente.

Cependant, aucune de ces caractéristiques n'est pathognomonique de chancre syphilitique. C'est pour cela qu'il faut évoquer le diagnostic de chancre syphilitique devant toute ulcération muqueuse aiguë, qu'il soit génital, oral ou anal. Concernant la localisation du chancre syphilitique, donc chez l'homme, le siège du chancre est assez électivement dans le sillon balanoprépuce, plus rarement sur le blanc ou sur le fourreau.

Chez la femme, le siège du chancre est le plus souvent sur la partie externe de la vulve, petites lèvres, grandes lèvres, fourchettes. Plus rarement, il est vaginal et comme il est indolore, il passe le plus souvent inaperçu. Dans les deux sexes, il peut y avoir des localisations buccopharyngées, anorectaux ou dans d'autres sièges au niveau de l'organisme en fonction de la nature des pratiques sexuelles.

Il y a des aspects cliniques atypiques concernant la taille des ulcérations et concernant les autres caractéristiques, notamment la douleur et l'induration. Donc classiquement, c'est une ulcération indolore et indurée, mais il peut y avoir des ulcérations qui sont douloureuses et des ulcérations qui sont souples et cependant ce sont des lésions du chancre syphilitique. Le chancre s'accompagne d'une adénopathie satellite non inflammatoire, le plus souvent unilatérale.

Dans certaines localisations, comme par exemple au niveau du col utérin et au niveau du rectum, l'adénopathie n'est pas cliniquement visible. Donc ici, on voit des ulcérations dues au chancre syphilitique. Donc à droite, ici vous voyez le caractère propre de l'ulcération.

Le fond, il est propre, il est rose. Donc la taille également, c'est typique. Et le siège au niveau du sillon parano-crépité, ici la même chose, une exussération superficielle qui siège au niveau du gland.

Donc d'autres lésions qui sont atypiques, ici vous voyez que c'est une ulsération qui est plus profonde. Ici, la taille est importante. Vous voyez un fond un petit peu plus long.

Ici, au lieu de voir une seule lésion, on a plusieurs ulsérations. Chez la femme, on voit deux ulsérations ici, donc au niveau des grandes lèvres. La même chose, deux lésions, une au niveau de la fourchette vulvaire, une ulsération au niveau de la muqueuse anale, une ulsération au niveau de la muqueuse anale.

Chez la femme, il peut y avoir une localisation profonde au niveau du col de l'utérus. Il peut y avoir des localisations au niveau des fesses, au niveau scrotal, au niveau de la lèvre. Même au niveau de la lèvre, l'ulsération garde ses caractéristiques, c'est-à-dire que c'est une ulsération qui est propre, qui est indolore, qui est indurée.

Ici, on voit d'autres localisations atypiques du champ carcéfilétique. Ici, au niveau de la paupière, ici au niveau du sein, au niveau du doigt. Ces localisations sont en fonction de la nature de la pratique sexuelle.

D'autres aspects cliniques atypiques. Ici, vous voyez un aspect inflammatoire important, vous voyez l'ulsération avec une inflammation importante, chose qu'on ne voit pas classiquement dans le champ carcéfilétique, on le voit surtout dans le champ clomo. Il peut y avoir des atypiques cliniques.

La même chose ici, on voit que ce sont des petites ulsérations et qu'on est devant plusieurs ulsérations, alors que classiquement, dans le champ carcéfilétique, on est devant une ulsération. Il y a des formes cliniques atypiques, en ce sont le nombre, la taille, la topographie, les caractères d'anxiété myologique, la douleur, l'induration. C'est pour cela qu'il faut évoquer un champ carcéfilétique devant toutes ulsérations de la muqueuse.

Le diagnostic de syphilis se fait par la mise en évidence du tréponème lui-même au microscope à fond noir. La sensibilité au niveau du champ est de 50 %. Il n'a aucune valeur au niveau buccal du fait de la possibilité de faux positifs. Il existe en effet des spirochettes s'adaptent au niveau de la muqueuse buccale.

Le tréponème, il ne se cultive pas in vitro. La deuxième méthode pour poser le diagnostic de la syphilis, c'est le diagnostic sérologique. C'est indirectement par la mise en évidence de la réponse spécifique.

Le sérodiagnostic de la syphilis est bien standardisé, peu coûteux et fiable. Dans la majorité des cas, on fait un test spécifique de tréponomatose TPHA et un test non spécifique VDRL pour

affirmer ou infirmer le diagnostic de syphilis. Il n'existe aucun test sérologique permettant de différencier les anticorps de la syphilis de ceux des tréponomatoses endémiques non vénériennes.

En effet, il existe certaines maladies dues au tréponéma autre que le tréponéma paludanme. Ils ont les mêmes sérologies. Il y a la maladie de VGL, la maladie de PINTA.

Ce sont des maladies qu'on trouve dans les pays tropiques. Concernant la réaction VDRL, c'est une réaction non spécifique. Pourquoi elle est non spécifique? Parce qu'elle utilise un antigène cardiolipidique et non pas un antigène tréponémique.

De ce fait, il peut y avoir des faux positifs. On peut trouver VDRL positif et TPHA négatif parce que c'est une réaction qui utilise un antigène cardiolipidique. Et cet antigène cardiolipidique peut se trouver dans certaines maladies immunitaires comme le lupus, par exemple, le syndrome des anticorps antiphospholipides.

Donc VDRL, c'est des abréviations. Donc VDRL, c'est en anglais Venereal Disease Research Laboratory. C'est une réaction qui met en évidence dans le sérum du patient des anticorps anticardiolipidiques.

C'est une réaction d'agglutination passive. La cinétique des anticorps est positive au moyen 8 à 10 jours après l'apparition du chancre. Puis le titre augmente ensuite rapidement pour atteindre un plateau durant la phase secondaire.

Et on va voir par la suite les différentes phases de la syphilis, la phase secondaire. La surveillance biologique de l'efficacité du traitement se fait sur le VDRL quantitatif. Ça, c'est très important.

Donc en général, l'intensité de l'agglutination détectée par la méthode qualitative, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est le dosage quantitatif parce que ça va nous permettre de suivre l'évolution de la maladie. Ainsi, par exemple, si on démarre le traitement, on considère que le traitement est efficace quand le titre de VDRL est divisé par 4, c'est-à-dire deux dilutions, six mois après le traitement.

Donc lorsque vous traitez le malade, par exemple, vous avez un malade qui a un taux d'anticorps de 1 sur 32, après six mois, il faut s'attendre à un taux de 1 sur 8. Sinon, ça veut dire que le traitement n'était pas efficace et il faut reprendre le traitement. Concernant les réactions spécifiques utilisant un antigène tréponémique, on a le test de Nelson qui utilise un tréponimum pallidum vivant, mais c'est un examen qui n'est pas de pratique courante et il est réservé à certains laboratoires de recherche. Il y a un risque de contagiosité pour le personnel.

On note également d'autres réactions spécifiques qui utilisent des antigènes tréponémiques avec un tréponimum pallidum tué. On a deux réactions FTA test. C'est une réaction

d'immunofluorescence indirecte nécessitant un microscope à fluorescence pour mettre en évidence cette réaction antigène-anticorps.

En général, on utilise cette réaction dans certaines situations particulières, notamment dans le cadre de la syphilis congénitale, mais pas pour le chancre syphilitique. Et vous avez la réaction qu'on utilise en pratique courante, donc la réaction TPHA, qu'on utilise bien sûr en association avec la réaction qu'on vient de voir tout à l'heure, la réaction VDRL. Donc TPHA, c'est la même chose, ce sont des abréviations, donc *tréponema pallidum* *emagrifinaceae*.

La réaction est spécifique des *tréponema*, donc la même chose, il ne permet pas de faire la différence entre *tréponema pallidum* et les autres *tréponema* non vénériennes. Donc c'est une réaction de magnétisation et ce qui est important ici, contrairement au VDRL, c'est surtout le dosage qualitatif, le dosage quantitatif n'est pas important parce que le titre de TPHA quantitatif n'est pas un bon marqueur de l'évolutivité de la maladie ni de la réponse au traitement, contrairement à la réaction VDRL qui permet de suivre le traitement. Pourquoi? Parce que ce titre varie de façon importante d'un examen à l'autre pour un même patient.

On peut trouver un taux aujourd'hui, par exemple 1 sur 340, et le lendemain, chez le même patient, on peut trouver un taux différent, donc 1 sur 600. Il n'y a pas de corrélation entre l'évolutivité de la maladie et le taux d'anticorps détecté par TPHA. Donc ce qui est important ici, c'est ce TPHA qualitatif, soit qu'il est positif, soit qu'il est négatif.

Si il est positif, ça confirme le diagnostic puisque c'est une réaction sérologique. S'il est négatif, ça élimine le diagnostic. Sur le plan cinétique, le TPHA est positif, à peu près la même chose que VDRL, autour du huitième, dixième jour du chancre.

L'intensité de la réaction augmente dans la syphilis secondaire que pour la réaction VDRL. Donc là, voici la cinétique de la sérologie en matière de syphilis. Donc on va commencer par la contamination.

Donc ici, la contamination. Et là, c'est l'intervalle entre la contamination et l'apparition du chancre syphilitique. On a dit qu'il est cet intervalle de trois semaines.

Et puis les anticorps apparaissent. Donc les anticorps détectés par VDRL et TPHA, on a dit que ce sont les deux réactions qu'on utilise en pratique courante. Le TPHA, on l'a dit, il est positif aux alentours du huitième, dixième jour après le chancre.

Le test de Nissan, on a dit que c'est un test qui utilise un antigène, un *tréponéma* palédon vivant. Il n'a pas d'intérêt en matière de chancre syphilitique parce qu'en général, il est positif aux alentours du G40. Et c'est un test, donc, réservé aux laboratoires de recherche.

Donc ce qu'on utilise, c'est TPHA et VDRL. On a dit que c'est une réaction qu'on utilise dans certaines situations particulières et notamment pour le diagnostic de la syphilis congénitale. Donc

si vous faites la sérologie avant l'apparition du chancre, vous aurez donc VDRL négatif, TPHA négatif.

Donc VDRL négatif, TPHA négatif n'élimine pas la syphilis. Il y a cette période avant l'apparition du chancre. Si vous avez un patient qui présente une ulcération génitale, donc qui est apparu trois semaines après un rapport sexuel, mais si vous faites la sérologie de façon précoce avant le huitième jour, vers G4, G3 ou même G5 parfois, vous aurez donc des réactions TPHA négatives et des VDRL négatifs.

Mais là, c'est l'interrogatoire, parce que lorsque vous avez un patient qui a un rapport sexuel, à ce moment-là, il faut demander la sérologie dix jours après l'apparition du chancre, sinon vous aurez une sérologie négative. Et de toute façon, il faut traiter. On demande la sérologie, mais on traite, on n'attend pas les résultats de la sérologie.

Donc on va voir par la suite, parce qu'il y aura un cours sur la syphilis, voir la syphilis primaire, la syphilis secondaire, la syphilis tertiaire et voir l'interprétation de manière globale de la réaction sérologique. Ce qui est important pour notre cours aujourd'hui, c'est cette partie-là, la syphilis primaire, où il y a le chancre syphilitique. Pour le traitement du chancre syphilitique, donc le traitement de référence est la benzatine pénicilline G, à raison de 2,4 millions d'unités en intramusculaire.

Si le patient est allergique à la pénicilline, on donne les cyclines. On préfère la doxycycline ou la tetracycline, qui a beaucoup d'effets secondaires sur le type digestif. On donne la doxycycline à raison de 100 mg x 2 par jour pendant 15 jours.

La tetracycline, 2 g par jour pendant 15 jours. L'érythromycine, 500 mg x 4 par jour pendant 15 jours. Pour les sujets contacts asymptomatiques, c'est-à-dire les partenaires qui ont une psychologie négative et qui n'ont pas de dilucidation génitale, on a deux attitudes.

Soit on continue à surveiller ces patients par une surveillance sérologique, donc TPA qualitative et DR quantitative, ou bien on donne un traitement à raison de benzatine pénicilline G, 2,4 millions d'unités en intramusculaire. C'est cette attitude qu'on choisit dans notre pratique courante, dans notre service. La surveillance clinique et biologique.

La surveillance clinique, c'est la disparition de l'ulcération et de l'adénopathie après l'installation du traitement. La surveillance sérologique se fait par la VDRN quantitative. On considère que le traitement est efficace quand le titre de VDRN est divisé par deux au troisième mois, ou bien divisé par quatre au sixième mois.

La sérologie peut, donc les anticorps peuvent se négativer en général après un an si le traitement a été installé de façon précoce. Sinon, il peut persister un taux d'anticorps faible, en général un sur deux, pendant plus de 24 mois. Après le chancre séquellitique, on va voir la deuxième météorologie, donc le chancre mou, appelé également chancrel.

Donc le chancre mou, il est dû au vacille de Dugré, qui est un vacille gramme négatif arrondi en chaîne, comme vous voyez dans cette image. La transmission, elle est sexuelle et c'est une maladie à contagiosité très grande. Donc l'incubation, elle est courte par rapport au chancre séquellitique.

Vous avez une incubation au moyen de trois jours. Ça commence par une macularité moteuse, puis l'apparition d'une pustule, puis l'apparition d'une ulcération purulente douloureuse. Donc cette ulcération s'associe à une adénopathie inflammatoire qui peut se fistuliser dans ce qu'on appelle le bubon.

L'évolution sous traitement, donc guérison rapide avec cicatrisation de l'ulcération, sans traitement, il peut y avoir des complications infectieuses. Donc voici les ulcérations, donc en général les purulentes. Il peut y avoir plusieurs ulcérations chez le patient.

Voici donc les purulentes, vous voyez le fond purulent, donc douloureuse, l'ulcération douloureuse et on arrive à rapprocher les verges, contrairement au chancre séquellitique. Comme pour le chancre séquellitique, il peut y avoir des formes cliniques atypiques. Des formes atypiques par la taille, donc il peut y avoir des ulcérations de petite taille, il peut y avoir des ulcérations géantes de grande taille.

L'aspect clinique, parfois au lieu d'avoir des ulcérations, on trouve plutôt des lésions ondulaires surmontées d'une ulcération ou des lésions papuleuses surmontées d'une ulcération. La topographie rejoint un petit peu donc celle du chancre séquellitique. Les complications, donc les vivants, la fistulisation de l'adénopathie, l'infongite de la verge, donc l'œdème important à cause de l'infection au niveau de la verge qui devient de grande taille, tuméfiée, inflammatoire.

Il peut y avoir des surinfections avec des abcès, donc un piogène. Le diagnostic positif, donc l'examen direct, il est sensible chez l'homme, mais il n'est pas sensible chez la femme puisqu'on peut trouver des vasculaires négatifs, ça profite de la muqueuse génitale. Donc chez l'homme, il est sensible, on peut faire des clôtures sur milieux spéciaux.

Le prélèvement peut être fait au niveau du chancre ou au niveau de vivants, en cas de fistulisation de l'adénopathie. Le diagnostic différentiel du chancre, ce sont les autres ulcérations génitales, la syphilis qu'on vient de voir tout à l'heure, l'herpès génital, l'aphthose génitale, la maladie de Nicolas Favre. Ce sont des maladies qu'on va voir par la suite.

Le traitement, en matière de maladies sexuellement transmissibles, il faut toujours privilégier le traitement en minutes. Donc on donne de la ciprofloxacine, 500 mg pour une seule prise. On donne de l'azithromycine, 1 g par voie orale.

La ceftriaxone, 250 ou 500 mg en intramusculaire, dose unique. Et l'érythromycine en dernier lieu, mais en général, ça demande plus de temps. Et on a dit qu'en matière de maladies sexuellement transmissibles, il faut stopper la chaîne de contamination, donc donner un

traitement minutes.

Ça permet l'observance, la compréhension du traitement du patient. Et il ne faut pas oublier de traiter le patient. Il peut y avoir, comme étiologie des ulcérations génitales, le chancre mixte.

Le chancre mixte, ça veut dire que soit on est devant un chancre cibitique qui se chancrilise, donc qui va perdre ses caractéristiques. Le chancre cibitique qui était douloureux, qui était propre, enduré, devient pérulant, devient douloureux, donc on dit que le chancre cibitique se chancrilise. Il prend les caractéristiques du chancromou.

Le chancromou peut se cibiliser. Donc là, lors d'un rapport sexuel, le malade peut être contaminé par les deux germes, par le tréponema palidum et par le bacillus ducrey. Puisque la durée d'incubation pour le bacillus ducrey est la plus courte, c'est le chancromou qui apparaît en premier.

Et puis par la suite, il y a l'apparition des signes sur la même ulcération, l'apparition du chancre cibitique. Ainsi, le chancromou va perdre ses caractéristiques. Donc le chancre devient induré, devient indoloreux.

On dit que le chancromou se cibilise, peut se cibiliser. Et dans ce cas, on donne un traitement qui vise les deux germes, donc la ciprofloxacine pour traiter le chancromou ou la ceftriaxone et benzatine pénicilline pour traiter la cibilis. Cette approche, c'est en général cette approche qu'on fait en pratique parce qu'on le vit souvent devant une ulcération génitale puisqu'il y a des formes atypiques.

On fait la sérologie, mais on donne dès le départ un traitement qui vise les deux germes. Donc un traitement dite syndromique à base de ciprofloxacine ou ceftriaxone et benzatine pénicilline. Donc on traite comme chancre.

Donc on a vu le chancre cibitique, le chancromou et le chancre mixte. Maintenant, on va voir les autres étiologies des ulcérations génitales. Vous avez l'herpès génital.

L'herpès génital, c'est une infection virale. Vous aurez un cours sur les infections virales et on va parler de l'herpès génital. Il y en a deux types, HSV1, herpès simplex type 1, atropisme buccal et type 2, atropisme génital.

Mais il peut y avoir des ulcérations génitales secondaires également à l'herpès simplex, donc type 1. Mais le plus souvent, c'est le type 2 qui donne une atteinte génitale. L'incubation de sept jours, donc après un rapport sexuel sept jours après, il y a l'apparition des lésions des vésicules, donc rappelez-vous de la définition des vésicules, des petites lésions à contenu liquidien clair ou des petites tailles de quelques millimètres de diamètre et ils se remplissent en laissant place à des érosions polycycliques douloureuses et irritantes. Il peut y avoir une lymphadénopathie bilatérale transposée à base d'acyclovir, donc on va détailler tout ça dans un

cours sur les infections herpès.

Voici les lésions, donc ici des vésicules. Le groupement, voici des vésicules que vous voyez ici avec des érosions, et donc les érosions polycycliques, cet aspect polycyclique, secondaire à la rupture des lésions vésiculeuses que vous voyez ici, donc les vésicules se rompent et laissent place à des érosions polycycliques douloureuses. Voici donc l'herpès.

L'herpès, il peut y avoir la primo-infection qui est plus importante, plus inflammatoire, avec des vésicules que vous voyez qui laissent place à des érosions, et il peut y avoir les récurrences. Donc le chancre scabieux. La même chose, il y aura un cours sur les ectoparasitoses, donc le chancre scabieux, il est dû au *Sarcoptes scabiei*, que vous voyez ici, c'est un parasite, c'est responsable de l'olagale.

Donc l'incubation, elle est de quelques jours à plusieurs semaines, et ce qui est important, le signe fonctionnel majeur, c'est le prurite le plus souvent familial, le prurite qui s'aggrave, qui s'exacerbe la nuit, et là, en général, c'est des papules qui sont excoriées au niveau du gland. Le traitement à base d'un scabieux. Voici donc, vous voyez, c'est des papules excoriées à cause du grattage.

Des papules excoriées à cause du grattage, et le chancre scabieux, il est considéré comme maladie sexuellement transmissible parce qu'il y a donc cette contamination lors du rapport sexuel, c'est par contact entre les deux partenaires. La donovanose, c'est une maladie qui n'existe pas sous le toit. On a vu, durant 20 ans plus d'exercice, un seul cas de donovanose chez un patient immunodéprimé.

Donc il est dû au *Calliornis bacterium granulomatosis*. L'incubation, ça peut varier entre 3 jours et 84 jours. Ça commence par une ulcération arrondie, abournée.

On va voir les images. Touche surtout la région inguinale. Donc le diagnostic histologique, vous voyez ici ce qu'on appelle l'existence de corps de donovans à l'histologie après une biopsie cutanée.

Le traitement, c'est à base de cicline ou trématoprim, sulfate, métoxazole pendant 15 jours. Voici les lésions et ces lésions avec la bordure qui est ourlée. Un fond granulomatique.

La maladie de Nicolas Favre est rare dans notre pays. Elle se trouve également dans certains pays africains, dans certains pays tropicaux. Elle est due au *Chlamydia trachomatis* sérotype L1, L2, L3.

L'incubation dure de 3 à 30 jours. Donc cliniquement, vous avez 3 stades. Stade 1, on trouve une papule éphémère ou une érosion, une ulcération, un douleur.

Stade 2, 2 fois sur 3, donc le patient développe des adénopathies inguinales unies ou bilatérales inflammatoires. Et stade 3, stade des séquelles avec éléphantiasis. On note également une

prédominance de la topographie anorectale chez la communauté homosexuelle masculine.

Le diagnostic se pose essentiellement par PCR, mettant en évidence du chlamydia trachomatis. Le traitement est à base de cyclines ou de rétro-médecines. Voici le premier stade, stade 1, donc une ulcération.

Stade 2, ulcération, vous avez l'adénopathie inflammatoire, vous la voyez ici. Et le stade 3, donc grosse bourse qu'on appelle éléphantiasis. Donc à côté de ces maladies qu'on vient de voir et qui sont des maladies sexuellement transmissibles, il peut y avoir d'autres étiologies.

Il peut y avoir des ulcérations au niveau de la muqueuse génitale qui sont des ulcérations post-traumatiques. Donc ça peut se voir dans le cadre, par exemple, de la pathomélie. La pathomélie, ce sont des troubles psychiques, c'est le malade qui s'auto-mutille, qui provoque ces ulcérations.

Ça peut être des ulcérations d'origine caustique. Par exemple, lors de l'hygiène intime, certains utilisent des antiseptiques qui sont irritants, qui nécessitent un rinçage. Il peut y avoir, donc, des ulcérations secondaires à des brûlures électriques, par exemple, ou par la chaleur lors de civis chez les enfants ou même dans la torture des sujets.

Donc ça peut exister, ce genre de pratique. Donc il faut être vigilant lorsqu'on examine les malades. Parmi les ulcérations, il y a l'aft génital qui peut être associé à l'aft buccal, et on parle d'aftos bipolaires, ou bien ça peut être des lésions génitales isolées sans atteinte buccale.

C'est des lésions qui évoluent par poussée et qui sont douloureuses et ressemblent aux chancres. Mais là, c'est l'interrogatoire qui permet de faire le diagnostic, et ces afts peuvent être isolés ou être secondaires à des maladies sous-jacentes. La maladie la plus fréquente, c'est la maladie de Beset, qui associe une atteinte ophtalmique et, donc, d'autres atteintes que vous allez voir dans le cours sur la maladie de Beset en médecine interne.

Maladie de Crohn et RCH, vous avez fait ça. Donc les manifestations extra-digestives de ces MICI, de ces maladies inflammatoires chroniques, il y a l'érythème noueux et il y a les afts pour les formes chroniques atrophiques, également c'est une maladie du système, et il y a des afts secondaires à des prises médicamenteuses, et il y a des afts idiopathiques contre pas d'étiologie. On peut voir également des ulcérations au niveau de la muqueuse génitale dans le cadre des toxérmies médicamenteuses.

Il y a certains médicaments qui peuvent donner des ulcérations localisées au niveau de la muqueuse génitale. Par exemple, vous avez le méthotrexate, où il y a donc des ulcérations de la muqueuse génitale, mais c'est donc une atteinte globale de la peau. Il y a une atteinte dans le cadre du syndrome de Steven Johnson et syndrome de Lyell.

Vous avez un décollement cutané étendu, et donc il y a une atteinte de la peau, y compris de la

muqueuse buccale et de la muqueuse génitale. Il y aura des cours également sur les toxédermies médicamenteuses. On peut voir également des ulcérations de la muqueuse génitale secondaire à la rupture des bulles dans le cadre des dermatoses bulleuses auto-immunes, donc pinfigus, pinfiguit, dermatose aiguillière, dermatose bulleuse acquise, et il y aura des cours donc détaillés sur les dermatoses bulleuses auto-immunes.

Donc, tout ce qu'on vient de voir, ce sont des ulcérations aiguës. Donc, si vous avez des ulcérations chroniques et la chronicité en général, la majorité, donc, différence entre ulcérations aiguës et ulcérations chroniques, donc après un mois d'évolution. Si vous avez une ulcération qui persiste plus d'un mois, vous êtes devant une ulcération chronique.

Et là, il faut faire une biopsie cutanée, il faut éliminer surtout un carcinome épidermoïde ou bien d'autres dermatoses inflammatoires chroniques, comme le nicaniorosif, la maladie de Bohin, la maladie de Pagès-Extrême-Amère, qui restent des dermatoses donc du domaine du spécialiste, et à ce moment-là, il faut faire une biopsie cutanée. Là, vous voyez des tumeurs. Ici, vous voyez la destruction de la verge.

Donc, c'est un homme, destruction de la verge, avec une adénopathie. Ça, c'est une métastase ganglionnaire. C'est un carcinome épidermoïde.

Donc, dans notre contexte, les malades, ils ne construisent pas, parce que à cause de la hantise, c'est une zone intime. Donc, on laisse évoluer des ulcérations et on voit des malades à ce stade avancé également. Ici, carcinome au niveau de la verge avec des adénopathies.

Là, c'est le carcinome épidermoïde. Et là, c'est un carcinome baso-cellulaire au niveau du versant cutané de la verge. Donc, en guise de conclusion, le message-clé de ce cours, c'est devant une ulcération génitale ou une érosion génitale récente, il faut penser aux IST.

Dans ce cas, donc, les ulcérations génitales sont dues surtout aux chancres syphilitiques, chancres mous, chancres mixtes et l'herpès. Les infections sexuellement transmissibles, en général, la prise en charge thérapeutique repose sur une approche syndromique. On traite une ulcération génitale comme une ulcération secondaire aux chancres mous et aux chancres syphilitiques.

On donne un traitement qui vise ces deux germes. En matière d'IST, la prévention est très importante et le médecin a un rôle important à jouer. Il doit éduquer les patients, les informer des différents risques et complications des maladies sexuellement transmissibles, les sensibiliser.

Et enfin, une ulcération génitale chronique doit faire éliminer un carcinome